HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ»

КОНСПЕКТ УРОКА

Вступительный урок

вялое пищеварение

О чём этот урок

Это вводный урок к **протоколу по вялому пищеварению**. По результатам диагностического теста у вас определён **вялый тип пищеварения**. Разбираем, что это значит, как он проявляется, какие диагнозы и риски с ним связаны, какие обследования можно пройти и как будет строиться работа на программе.

Вялый тип пищеварения — не официальный диагноз, а собирательный термин для **сниженной активности пищеварительной системы**: пища переваривается медленно и некачественно, а процесс сопровождается неприятными симптомами.

1. Как проявляется вялое пищеварение

Чем больше признаков, тем сильнее выражено замедленное пищеварение.

Основные признаки

✔️ тяжесть после еды

✔️ слабые тупые боли в правом подреберье

✔️ вздутие живота сразу после еды

✔️ метеоризм, газообразование после любой еды — и даже после прохладных напитков

✔️ ощущение, что еда долго стоит в желудке и медленно переваривается

✔️ переполненность желудка после еды, «ком в желудке»

✔️ изжога после мучного, сладкого, крахмалистого (картофель, рис)

✔️ частая отрыжка

✔️ тошнота на жирную и/или белковую еду

✔️ возможны запоры, но возможна и диарея — зависит от состояния ферментов тонкой кишки

✔️ тонкий белый налёт, равномерно распределённый по языку

Другие возможные жалобы

- **ком в горле** — утром хочется откашлять мокроту;
- **хроническая заложенность носа;**
- **сонливость, усталость, фоновый упадок сил;**
- **снижение аппетита** — вплоть до того, что до 12–13 часов не хочется есть; к вечеру аппетит появляется;
- **тяга к кислой и острой пище;**
- **отёки лица и тела;**
- **повышенный холестерин;**
- **кандидоз.**

Сезонность. Жалобы могут быть постоянными или пропадать в тёплое время года и усиливаться осенью, зимой и весной: в холодные сезоны замедляется обмен веществ и естественным образом снижается функция щитовидной железы.

2. Что происходит в ЖКТ и характерные диагнозы

По сути вялое пищеварение — это:

- замедленное опорожнение желудка, сниженная моторика;
- недостаточная секреция желудочного сока, ферментов поджелудочной и кишечника, желчи;
- сниженный тонус мускулатуры органов ЖКТ;
- нарушение моторики кишечника и брожение в нём — отсюда вздутие;
- нарушение регуляции ЖКТ через вегетативную нервную систему.

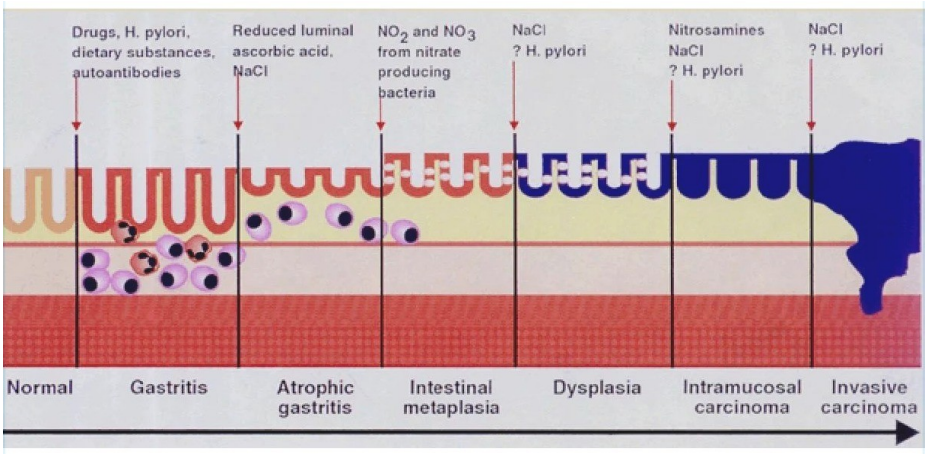
Функциональные расстройства	Органические патологии
✔️ диспепсия — нарушение пищеварения в желудке ✔️ дискинезия желчевыводящих путей по гипокинетическому типу — замедленный отток желчи ✔️ функциональная изжога ✔️ сладж жёлчного пузыря — вязкая «замазкообразная» желчь; затем могут образоваться камни ✔️ ферментопатия — дефицит пищеварительных ферментов ✔️ атонический запор — такой диагноз ставят редко, хотя по сути при вялом типе развивается именно он	✔️ гастрит с пониженной кислотностью ✔️ хеликобактерная инфекция желудка ✔️ атрофический гастрит ✔️ диффузные изменения поджелудочной железы или липоматоз поджелудочной (по результатам УЗИ)

3. Риски вялого пищеварения

Риск	Почему
Дефицит белка, железа, B12 и других витаминов и микроэлементов	Пища плохо переваривается — питательные вещества плохо усваиваются. Это в том числе снижает обмен веществ и нарушает функцию щитовидной железы
Дисбиоз кишечника	—
Желчнокаменная болезнь	Склонность к формированию сладжа

Риск	Почему
Жировая болезнь печени	При далеко зашедшем, годами накапливающемся вялом пищеварении
Воспалительные заболевания ЖКТ	При определённых обстоятельствах вялый тип может перейти в воспалённый
Метаплазия кишечного типа в желудке	В небольшом проценте случаев — см. каскад Корреа

Каскад Корреа — стадии развития гастрита



Каскад Корреа (схема из презентации)

Стадия на схеме	Что происходит
Normal	Нормальная слизистая желудка
Gastritis	Присоединяется хеликобактерная инфекция, развивается воспаление — гастрит
Atrophic gastritis	Атрофический гастрит: слизистая сглаженная, ворсинки сглажены
Intestinal metaplasia	Кишечная метаплазия: в желудке появляются клетки кишечного типа, которых там быть не должно
Dysplasia → carcinoma	В небольшом проценте случаев — развитие онкологии желудка

Чем опасен вялый тип: при нём нет острых болей, как при других типах. Есть тяжесть, вздутие, «ком в желудке» — «у многих же есть, попью ферменты, и всё будет в порядке». А неприятная ситуация может развиваться «тихой сапой» — годами, иногда десятилетиями. Поэтому даже при этом, вроде бы самом безобидном типе важно **не пропустить шаг обследования**.

4. Какие обследования можно пройти

Для программы это **необязательный шаг**: по жалобам и так понятно, что происходит с ЖКТ и какое питание, специи и травы нужны, чтобы его «взбодрить». Но чтобы точно оценить, на каком этапе вы находитесь, обследоваться очень полезно.

Важно: точный список анализов для вашего случая назначает **врач-гастроэнтеролог**. Результаты оцениваются в комплексе — нет одного анализа, по которому сразу всё понятно.

4.1. УЗИ органов брюшной полости

Базовый простой анализ. Оценивает **печень, поджелудочную железу, жёлчный пузырь**: структурные изменения, сладж, утолщение стенок пузыря, полипы и т. д.

4.2. Оценка функций желудка

Обследование	Что даёт
Кровь на «Гастропанель»: пепсиноген I/II, гастрин-17, антитела к H. pylori	Самый простой и психологически лёгкий вариант — кровь из вены. Позволяет до некоторой степени оценить слизистую и наличие атрофии, воспаление, вероятность атрофического гастрита, кислотность (повышенная или пониженная), хеликобактерную инфекцию — активную или перенесённую. Если боитесь ФГДС, можно начать с гастропанели и по её итогам решить, нужна ли ФГДС
ФГДС (фиброгастродуоденоскопия)	Тонкая трубка с камерой: оценивает пищевод, смыкание клапанов желудка, структуру слизистой, воспаление. Берётся биопсия в нескольких точках — для диагностики H. pylori и оценки клеток слизистой. Входит в европейские и американские протоколы после 45 лет раз в 2–3 года: выявляет проблемы на ранней стадии. Сейчас делается под седацией

Обследование	Что даёт
24-часовая pH-метрия	Маленький зонд сутки находится в желудке: оценивает кислотность, а также тяжесть и частоту рефлюксов при ГЭРБ (частые забросы, отрыжка)

Сдавать все три не обязательно — гастроэнтеролог, скорее всего, порекомендует один или два.

4.3. Анализы крови

Показатели	Что оценивают
АЛТ, АСТ, ГГТ, щелочная фосфатаза, билирубин общий и прямой	Функция печени и желчевыводящих путей: воспаление, застой желчи, склонность к камнеобразованию
Общий белок, альбумин	Усвоение белка — оно страдает при вялом пищеварении
Общий анализ крови, ферритин, B12 и фолиевая кислота (по желанию)	Дефицит железа и кофакторов, которые помогают ему усваиваться и превращаться в гемоглобин и эритроциты

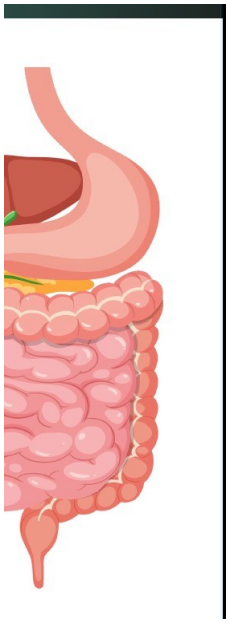
4.4. Анализы кала

- **Кал на панкреатическую эластазу** — один из лучших анализов функции поджелудочной: сколько ферментов она выделяет и насколько эффективно. Особенно если часто вздувает «на всё подряд».
- **Копрограмма** — совокупная оценка функций всех отделов ЖКТ. Покажет, что нарушения есть, но не всегда — в каком отделе. Хороша как дополнительный анализ, не как основной.

4.5. Водородно-дыхательный тест (СИБР-тест)

Если вздувает «на всё подряд», особенно на ферментированное (квашеная капуста и овощи, комбуча, кисломолочное) и на пробиотики. Оценивает **СИБР** — синдром избыточного бактериального роста, а также непереносимость лактозы, фруктозы и других сахаров. Доступен во многих лабораториях.

5. Цель программы — восстановить активность вялого пищеварения



- **восстановить моторику ЖКТ и желчевыделение;**
- **поддержать слизистые оболочки** и не дать развиться воспалению, если есть риски;
- **улучшить переваривание пищи и всасывание питательных веществ;**
- **наладить нервную регуляцию работы ЖКТ;**
- **повысить качество жизни и энергию** — жалобы уменьшаются или проходят.

Программа длится **5 недель**. Работаем с оттоком желчи, синтезом соляной кислоты в желудке, синтезом ферментов поджелудочной и кишечника, нормализацией моторики.

Как мы будем работать

1. **Налаживание режима дня.**
2. **Регуляция нервной системы**, снижение хронического стресса.
3. **Коррекция питания**: убрать то, что мешает пищеварению, и добавить продукты-стимуляторы ЖКТ.
4. **Полноценное разнообразное меню**, закрывающее дефициты питательных веществ.
5. **Специи и травы.**
6. **Домашние процедуры.**

Всё вводим пошагово, постепенно, начиная со второй недели.

> **Задание на первую неделю:** зайдите в другие уроки недели — там списки специй и трав, рецепты напитков и первые рецепты блюд, которые можно приготовить заранее (например, ферментированные овощи). Проверьте, что есть дома, докупите недостающее — со следующей недели начинаем активную работу.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое вялый тип пищеварения? Это диагноз?
2. Назовите основные признаки вялого пищеварения.
3. Какие ещё жалобы могут сопровождать вялый тип? Почему они могут усиливаться в холодное время года?
4. Какие процессы в ЖКТ лежат в основе вялого пищеварения?
5. Какие функциональные расстройства характерны для вялого типа? Что такое сладж и гипокинетическая дискинезия?
6. Какие органические патологии могут быть выявлены при вялом типе?
7. Какие риски несёт вялое пищеварение? Почему развиваются дефициты?
8. Опишите стадии каскада Корреа.
9. Почему вялый тип опасен, несмотря на отсутствие острых болей?
10. Что показывает УЗИ органов брюшной полости при вялом пищеварении?
11. Что оценивает анализ крови «Гастропанель» и в каких случаях с него удобно начать?
12. Что даёт ФГДС с биопсией и кому её рекомендуют проходить регулярно?
13. Для чего нужна 24-часовая pH-метрия?
14. Какие анализы крови помогают оценить работу печени, усвоение белка и дефицит железа?
15. Чем панкреатическая эластаза отличается от копрограммы по информативности?
16. Когда стоит сделать водородно-дыхательный тест и что он показывает?
17. Какие цели у программы при вялом пищеварении и через какие методы мы их достигаем?